Ruang Belajar Nadia

BLOK REPRODUKSI · RANGKUMAN

Panduan Resmi

Rangkuman Buku Panduan Resmi Blok Reproduksi: Modul Blok 2026, Buku KIA 2024, dan WHO ANC 2016

Tim Blok Reproduksi FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang · Kemenkes RI · WHO

Disusun dari Modul Pembelajaran Blok Reproduksi TA 2025/2026 (Dr. dr. Nurlaili Susanti, M.Biomed dan dr. Nurfianti Indriana, SpOG), Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kemenkes RI 2024, dan WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience (2016). File asli ketiganya bisa diunduh di web Ruang Belajar Nadia (Buku KIA dibagi 2 bagian karena ukurannya besar). Pembahasan klinis lengkap WHO ANC dan Buku KIA ada di Rangkuman KUL 1.

istilah = kata sulit, artinya ada di kotak **Kamus kecil** atau langsung di kalimatnya · Penting Jebakan soal Update guideline Kamus kecil Contoh kasus

0. Isi Paket Panduan

Dokumen	Isinya	Dipakai untuk
Modul Blok Reproduksi 2026	Deskripsi blok, daftar masalah dan penyakit (SKDI), metode pembelajaran, **penilaian**, **topik dan pokok bahasan tiap kuliah**, tugas EBM, dan **4 skenario tutorial**	Peta belajar: tahu apa saja yang keluar di UAB dan sampai level apa
Buku KIA 2024	Buku yang dipegang ibu: jadwal periksa hamil, **12T**, porsi makan, tanda bahaya, persalinan, **nifas (KF 1–4)**, bayi baru lahir (KN 1–3), menyusui	Standar pelayanan ibu dan anak di Indonesia (sering jadi dasar soal)
WHO ANC 2016	**49 rekomendasi** ANC dan model **8 kontak**	Standar internasional; dibandingkan dengan aturan Indonesia

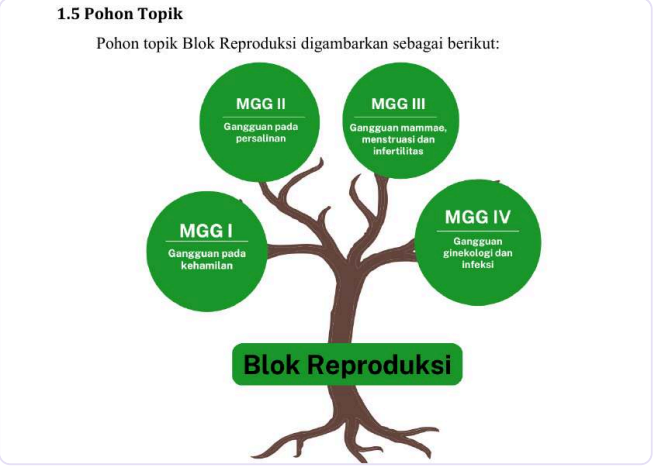
⭐ **Penting**

Cara memakai: baca **Bab 1** (modul) dulu untuk tahu **topik dan level SKDI**, lalu buka rangkuman KUL yang sesuai. Untuk WHO dan Buku KIA, bab di sini hanya **ringkasan cepat**; versi lengkap dengan gambar ada di **Rangkuman KUL 1**.

1. Modul Blok Reproduksi 2026

1.1 Gambaran blok

1. **Blok ke-15**, bobot **5 SKS**, semester 5, **5 minggu** (4 minggu belajar aktif + 1 minggu ujian).
2. Membahas penyakit sistem reproduksi dari **epidemiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, penunjang, sampai tatalaksana sesuai kompetensi dokter umum**.
3. Pendekatan **SPICES** dengan **PBL (problem-based learning)** sebagai metode utama, ditambah sudut pandang **etika kedokteran dan nilai Islam**.
4. Tema per minggu: **Minggu 1 gangguan kehamilan**, **Minggu 2 gangguan persalinan**, **Minggu 3 mammae, menstruasi, dan infertilitas**, **Minggu 4 ginekologi dan infeksi**.



Dari modul: pohon topik Blok Reproduksi. Minggu I gangguan pada kehamilan, Minggu II gangguan pada persalinan, Minggu III gangguan mammae, menstruasi, dan infertilitas, Minggu IV gangguan ginekologi dan infeksi. *Sumber: Modul Blok Reproduksi 2026 (FKIK UIN Malang)*

1.2 Penilaian dan syarat lulus

Komponen	Bobot	Rincian
Ujian Akhir Blok (UAB)	**60%**	MCQ berbasis komputer (CBT), **seluruh topik kuliah**
Tutorial	10%	Diskusi 50% + laporan 50%
Praktikum	10%	Pretest 25% + laporan 25% + responsi 50%
TBL	10%	iRAT 20%, tRAT 35%, tAPP 35%, peer assessment 10%
Tugas terstruktur (EBM)	10%	Laporan 50, presentasi 30, menjawab pertanyaan 20

1. **Konversi nilai**: 81–100 **A**, 76–80 B+, 71–75 B, 66–70 C+, 61–65 C, 51–60 D, 0–50 E.

2. **Syarat lulus blok: nilai akhir minimal 60 (C)**.
3. Karena UAB 60%, **semua kuliah wajib dikuasai**, bukan hanya topik tutorial.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **TBL (Team Based Learning)**: belajar di kelas dengan soal. **iRAT**: tes kesiapan individu; **tRAT**: tes yang sama dikerjakan berkelompok; **tAPP**: soal aplikasi kelompok. **Seven jumps**: 7 langkah tutorial PBL (klarifikasi istilah, identifikasi masalah, curah pendapat, analisis/peta masalah, tujuan belajar, belajar mandiri, pelaporan + peta konsep).

1.3 Daftar kuliah dan pokok bahasan

Penomoran **di modul** dimulai dari "Kuliah pengantar" sebagai nomor 1, sehingga berbeda satu angka dengan penomoran **folder kating** yang dipakai di web ini. Tabel di bawah menyamakan keduanya.

Modul	Topik	Pokok bahasan (level SKDI)	Dosen	Di web
1	Pengantar blok	Modul, kontrak kuliah	SAN	–
2	ANC dan gangguan awal kehamilan	ANC (4), kehamilan risiko (4), skrining PTM (4) dan PM (4), hiperemesis (3B), anemia (3A), TORCH, malaria, hepatitis B (3A)	ADI	**KUL 1**
3	Perdarahan kehamilan muda	Abortus mengancam (3B), inkomplit (4), komplit (4), KET (3B), mola (2), kuretase < 10 minggu (4)	NUR	KUL 2
4	Perdarahan kehamilan lanjut	Plasenta previa (2), solusio (3B), vasa previa (2), syok (3B)	NUR	KUL 3
5	Patologi neonatus	PJT, IUFD, gemelli, kembar siam, polihidramnion, kelainan janin, inkompatibilitas darah (semua 2)	NUR	KUL 4
6	Gangguan metabolik kehamilan	Hipertensi (3A), preeklamsia (3B), eklamsia (3B), DMG (3A), insufisiensi plasenta (2)	NUR	KUL 5

Modul	Topik	Pokok bahasan (level SKDI)	Dosen	Di web
7	USG	Rujukan USG (4), USG obstetri (3), CTG (3)	NUR	**KUL 6**
8	Asuhan persalinan normal	Pelvimetri, tanda dan tahap persalinan, partograf, tromboflebitis, inkontinensia urin/feses pascasalin (2)	NUR	**KUL 7**
9	Persalinan dengan tindakan	Episiotomi (4), induksi kimiawi (3), vakum rendah (3), sungsang (3), SC (1)	NUR	**KUL 8**
10	Patologi dalam persalinan	Preterm (3B), postterm (2), KPD (3B), inkompetensi serviks (2), korioamnionitis (3B), kortikosteroid (4)	NUR	**KUL 9**
11	Penyulit persalinan	Malpresentasi, letak janin > 36 minggu, CPD (2); distosia, partus lama, prolaps tali pusat, hipoksia janin, ruptur uteri (3B)	NUR	**KUL 10**
12	Perdarahan postpartum	HPP, syok, robekan serviks, ruptur perineum 3–4, retensio, inversio, subinvolusio (3B); ruptur perineum 1–2, anestesi lokal, kompresi bimanual (4)	NUR	**KUL 11**
13	Tinjauan etik dan keislaman	Terminasi kehamilan, status embrio, pro-life vs pro-choice, kontrasepsi permanen, ART	DOB	**KUL 12**
14	Gizi ibu hamil dan menyusui	Nutrisi hamil normal dan bermasalah (DM, HT), menyusui normal dan bermasalah (alergi)	LRS	**KUL 13**

Modul	Topik	Pokok bahasan (level SKDI)	Dosen	Di web
15	Pubertas, menstruasi, infertilitas	Pubertas terlambat (2), PUA (3A), dismenore, menopause (2), infertilitas (3A), amenore, kurva suhu basal (4), inseminasi (1)	NUR	menunggu PPT
16	Obgyn sosial	Kematian ibu dan bayi, perkosaan, visum, kehamilan remaja, HIV, IMS, gangguan jiwa hamil–nifas	ADI	menunggu PPT
17	Kontrasepsi	Macam KB, suntik (4), konseling (4), komplikasi KB (4)	NUR	menunggu PPT
18	Nifas dan laktasi	Perawatan nifas (4), infeksi nifas (4), engorgement, mastitis, cracked dan inverted nipple (4), abses (2)	ADI	menunggu PPT
19	Tumor mammae	FAM, karsinoma payudara, ginekomastia, hipomastia (2), SADARI (4)	DANA	menunggu PPT
20	Farmakologi sistem reproduksi	Hormonal, induksi ovulasi, motilitas uterus, anti-infeksi	SAN	menunggu PPT
21	Farmakologi hamil dan laktasi	Obat dan ASI, obat saat hamil, obat saat menyusui	SAN	menunggu PPT
22	Infeksi genitalia	Toksoplasmosis (3A), kandida, vaginitis, BV, servisitis (4), PRP (3A)	NUR	**KUL 21**

Modul	Topik	Pokok bahasan (level SKDI)	Dosen	Di web
23	Kelainan genitalia	Malformasi (1), endometriosis (2), sistokel/rektokel (1), prolaps (3A), pesarium (3), fistula (2), korpus alienum (3A)	NUR	**KUL 22**
24	Tumor genitalia eksterna	Abses folikel (4), kista/abses Bartholin, Gartner, Naboth (3A), polip (2), vulnus (3B)	ADI	menunggu PPT
25	Tumor genitalia interna	Dermoid, kista ovarium, mioma/adenomiosis, PCOS, kanker endometrium, ovarium, serviks, koriokarsinoma (2), torsi/ruptur kista (3B)	ADI	menunggu PPT
26	Patologi anatomi	PA kelainan organ reproduksi wanita dan payudara (+ praktikum minggu 3)	FEB	menunggu PPT
27	Mikrobiologi	Gardnerella, Bacteroides, Treponema, gonore, klamidia, herpes, toksoplasma, trikomonas	VI	menunggu PPT

⚠️ **Jebakan soal**

Level SKDI menentukan **kedalaman soal**. Topik **level 4** (misalnya abortus inkomplit, ruptur perineum 1–2, kandida, BV, mastitis, KB suntik) biasanya ditanya sampai **dosis dan langkah tindakan**. Topik **level 2** cukup **diagnosis dan rujuk**.

1.4 Skenario tutorial (untuk latihan berpikir)

Skenario	Kasus singkat	Kata kunci	Arah diagnosis
1. "Apa yang terjadi pada kehamilanku"	Ny. A 25 th, primigravida, HPHT 6 minggu, mulas dan keluar darah dengan gumpalan seperti daging; 3 hari sebelumnya flek	Portio **tertutup**, kanalis tidak teraba jaringan, fundus tidak teraba, konjungtiva anemis	**Abortus komplit** (sebelumnya abortus iminens) → lihat KUL 2
2. "Terasa cairan keluar tidak bisa ditahan"	Ny. B 29 th, G2, 36 minggu, cairan merembes, kontraksi makin sering; TB 140 cm, BB 85 kg; leukosit 13.000; AFI 6	Rembes jernih, dilatasi 3 cm, ampisilin + deksametason, lahir 2.490 g	**KPD preterm (36 minggu)** → **persalinan preterm**; TB < 145 cm (risiko panggul sempit) → KUL 9 dan 10
3. "Payudaraku sakit"	Ny. C 24 th, 14 hari pascasalin, payudara kiri bengkak merah keras, puting pendek dan lecet, demam 38,5 °C; lokia rubra berbau; pantang lauk hewani	TFU 2 jari bawah pusat di hari 14 (seharusnya tidak teraba)	**Mastitis** + **puting lecet/pendek** + **infeksi nifas/subinvolusi** + gizi kurang karena pantangan → KUL Nifas, KUL 13
4. "Gatal banget"	Ny. D 25 th, obesitas (BB 80 kg/TB 155 cm), keputihan seperti susu pecah, panas dan gatal, sering cuci dengan sabun	Gumpalan seperti keju, **pseudohifa**	**Vulvovaginitis kandida** → KUL 21

1.5 Pertanyaan EBM (tugas terstruktur)

Format **PICO**, cari di PubMed/Scopus/Google Scholar, telaah dengan **CASP checklist**:

1. Besi oral **harian vs intermiten** pada anemia defisiensi besi ibu hamil.
2. **Vitamin B6 vs nonfarmakologis** pada mual-muntah kehamilan.
3. **Manajemen aktif kala III vs fisiologis** untuk mencegah HPP.
4. **Oksitosin vs misoprostol** untuk mencegah HPP.
5. **NSAID vs parasetamol** pada dismenore primer.
6. **Implan vs suntik progestin** untuk kontrasepsi jangka panjang.
7. **Antibiotik + pengosongan payudara vs suportif** pada mastitis tanpa abses.
8. **Kompres dingin vs perawatan rutin** pada breast engorgement.
9. **Metronidazol oral vs intravaginal** pada vaginosis bakterial.
10. **Probiotik (Lactobacillus) vs edukasi higiene** pada kandidiasis vulvovaginal.

📖 **Kamus kecil**

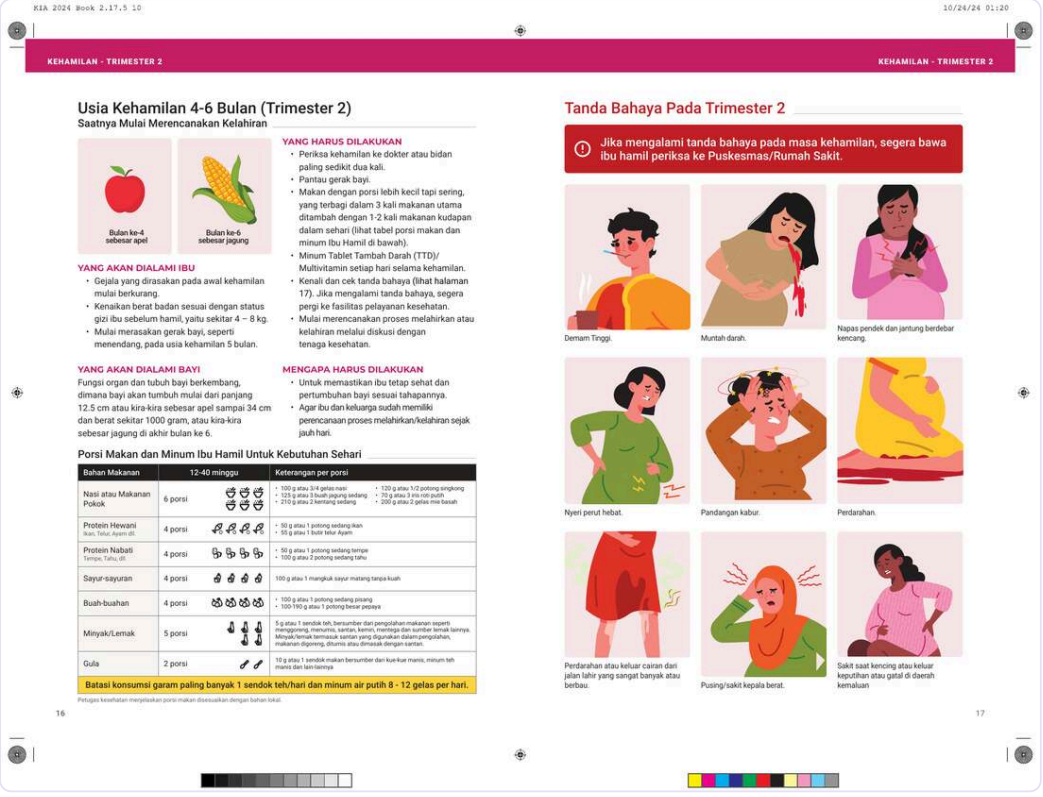
PICO: Patient/Problem, Intervention, Comparison, Outcome. **CASP**: Critical Appraisal Skills Programme, daftar tilik untuk menilai mutu artikel (RCT, systematic review, kohort, kasus-kontrol).

2. Buku KIA 2024: Ringkasan Cepat

2.1 Pemeriksaan kehamilan

1. **Minimal 6 kali** dengan rumus **1–2–3** (trimester 1: 1 kali, trimester 2: 2 kali, trimester 3: 3 kali).
2. **Dokter minimal 2 kali**: **trimester 1** (≤ 12 minggu) dan **trimester 3** (32–36 minggu), masing-masing dengan **USG**.
3. Standar pelayanan **12T**: timbang BB dan ukur TB, tekanan darah, **LiLA**, **TFU**, presentasi janin dan **DJJ**, skrining dan imunisasi **Td**, **TTD/MMS** setiap hari, **laboratorium** (Hb, protein urin, golongan darah, gula darah, **triple eliminasi HIV–sifilis–hepatitis B**), tata laksana kasus, **temu wicara**, **USG**, dan **skrining kesehatan jiwa**.

Trimester	Jumlah minimal	Keterangan
1 (≤ 12 minggu)	1 kali	Oleh **dokter**: anamnesis, fisik, **USG**, laboratorium lengkap
2 (> 12–24 minggu)	2 kali	Dokter atau bidan
3 (> 24 minggu–lahir)	3 kali	Salah satunya **oleh dokter** pada 32–36 minggu: USG, laboratorium, rencana tempat bersalin



Dari Buku KIA 2024: halaman usia kehamilan 4–6 bulan (trimester 2), berisi hal yang dialami ibu dan bayi, porsi makan dan minum ibu hamil sehari, serta tanda bahaya trimester 2 (demam, muntah terus, janin kurang bergerak, keluar cairan, perdarahan, sakit kepala hebat, pandangan kabur, bengkak). *Sumber: Buku KIA Kemenkes RI 2024*

2.2 Porsi makan ibu hamil dan menyusui (Buku KIA)

Bahan makanan	Hamil TM1	Hamil TM2–TM3	Menyusui	Contoh 1 porsi
Nasi/makanan pokok	5 porsi	6 porsi	6 porsi	100 g (¾ gelas) nasi, 3 jagung sedang, 2 kentang sedang, 3 iris roti
Protein hewani	4 porsi	4 porsi	4 porsi	50 g ikan (1 potong sedang), 1 butir telur
Protein nabati	4 porsi	4 porsi	4 porsi	50 g tempe, 100 g tahu
Sayur	4 porsi	4 porsi	4 porsi	1 mangkuk sayur matang tanpa kuah
Buah	4 porsi	4 porsi	4 porsi	1 pisang, 1 potong besar pepaya
Minyak/lemak	5 porsi	5 porsi	6 porsi	1 sendok teh minyak
Gula	2 porsi	2 porsi	2 porsi	1 sendok makan gula
Air	8–12 gelas	8–12 gelas	**14 gelas** (0–6 bulan), **12 gelas** (6–12 bulan)	

🆕 **Update guideline**

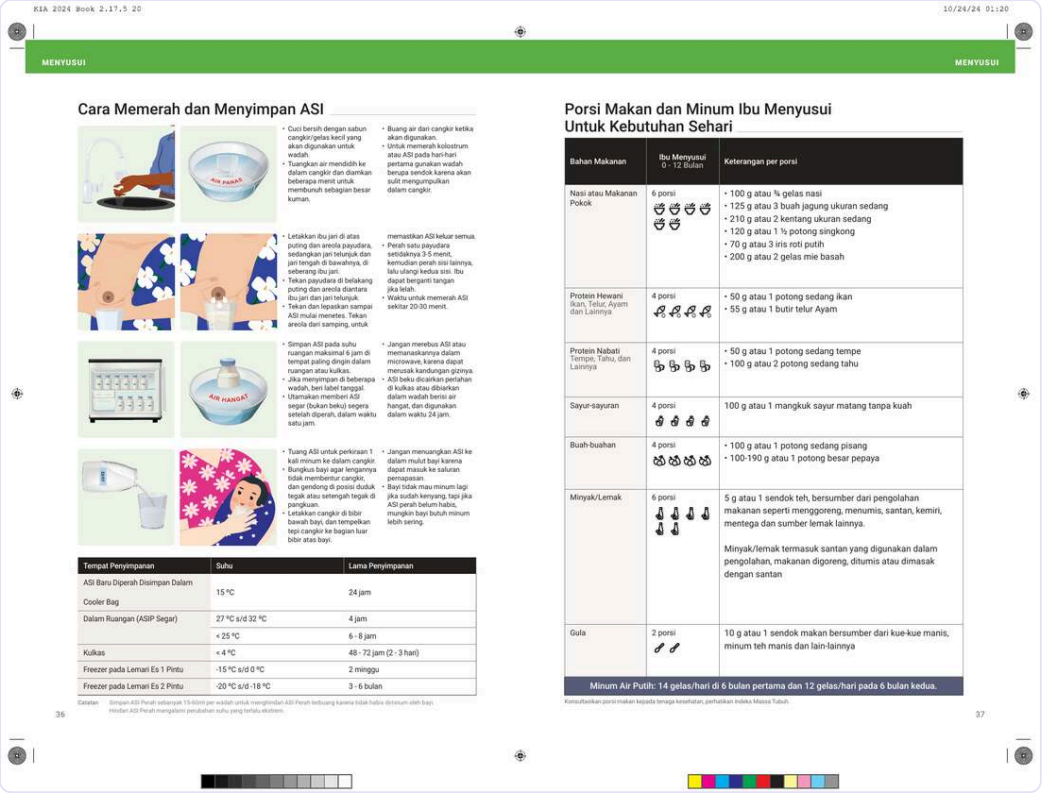
Angka porsi di atas mengikuti tabel Buku KIA 2024 halaman per trimester. Garam dibatasi **paling banyak 1 sendok teh per hari**. Penjelasan zat gizi lengkap ada di **Rangkuman KUL 13**.

2.3 Nifas, bayi baru lahir, dan ASI

Kunjungan	Waktu
KF 1	**6 jam – 2 hari** pascasalin
KF 2	**3 – 7 hari**
KF 3	**8 – 28 hari**
KF 4	**29 – 42 hari**
KN 1	**6 – 48 jam** setelah lahir
KN 2	**3 – 7 hari**
KN 3	**8 – 28 hari**

1. Perawatan nifas **6 jam sampai 42 hari** pascasalin, **paling sedikit 4 kali**.

2. Bayi 0–6 jam: **IMD**, **vitamin K1**, **salep/tetes mata antibiotik**, **imunisasi hepatitis B**; lalu **skrining hipotiroid kongenital (SHK)**.
3. **Penyimpanan ASI perah** (Buku KIA): suhu ruang 27–32 °C **4 jam**; < 25 °C **6–8 jam**; kulkas < 4 °C **2–3 hari**; freezer 1 pintu **2 minggu**; freezer 2 pintu **3–6 bulan**; cooler bag 15 °C 24 jam.



KIA 2024 Book 2.17.5 20 10/24/24 01:20

MENYUSUI MENYUSUI

Cara Memerah dan Menyimpan ASI

- Cuci bersih dengan sabun cangkir/gelas kecil yang akan digunakan untuk wadah.
- Tuangkan air mendidih ke dalam cangkir dan diamkan beberapa menit untuk membunuh sebagian besar kuman.
- Buang air dari cangkir ketika akan digunakan.
- Untuk memerah kolostrum atau ASI pada hari-hari pertama gunakan wadah berupa sendok karena akan sulit mengumpulkan dalam cangkir.

AIR PANAS

- Letakkan ibu jari di atas puting dan areola payudara, sedangkan jari telunjuk dan jari tengah di bawahnya, di seberang ibu jari.
- Tekan payudara di belakang puting dan areola diantara ibu jari dan jari telunjuk.
- Tekan dan lepaskan sampai ASI mulai menetes. Tekan areola dari samping, untuk memastikan ASI keluar semua.
- Perah satu payudara setidaknya 3-5 menit, kemudian perah sisi lainnya, lalu ulangi kedua sisi. Ibu dapat berganti tangan jika lelah.
- Waktu untuk memerah ASI sekitar 20-30 menit.

- Simpan ASI pada suhu ruangan maksimal 6 jam di tempat paling dingin dalam ruangan atau kulkas.
- Jika menyimpan di beberapa wadah, beri label tanggal.
- Utamakan memberi ASI segar (bukan beku) segera setelah diperah, dalam waktu satu jam.
- Jangan merebus ASI atau memanaskannya dalam microwave, karena dapat merusak kandungan gizinya.
- ASI beku dicairkan perlahan di kulkas atau disiarkan dalam wadah berisi air hangat, dan digunakan dalam waktu 24 jam.

AIR HANGAT

- Tuang ASI untuk perkiraan 1 kali minum ke dalam cangkir.
- Bungkus bayi agar lengannya tidak membentur cangkir, dan gendong di posisi duduk tegak atau setengah tegak di pangkuan.
- Letakkan cangkir di bibir bawah bayi, dan tempelkan tepi cangkir ke bagian luar bibir atas bayi.
- Jangan menuangkan ASI ke dalam mulut bayi karena dapat masuk ke saluran pernapasan.
- Bayi tidak mau minum lagi jika sudah kenyang, tapi jika ASI perah belum habis, mungkin bayi butuh minum lebih sering.

Tempat Penyimpanan	Suhu	Lama Penyimpanan
ASI Baru Diperah Disimpan Dalam Cooler Bag	15 °C	24 jam
Dalam Ruangan (ASIP Segar)	27 °C s/d 32 °C	4 jam
	< 25 °C	6 - 8 jam
Kulkas	< 4 °C	48 - 72 jam (2 - 3 hari)
Freezer pada Lemari Es 1 Pintu	-15 °C s/d 0 °C	2 minggu
Freezer pada Lemari Es 2 Pintu	-20 °C s/d -18 °C	3 - 6 bulan

Catatan: Simpan ASI Perah sebanyak 15-60ml per wadah untuk menghindari ASI Perah terbuang karena tidak habis diminum oleh bayi. Hindari ASI Perah mengalami perubahan suhu yang terlalu ekstrem.

36

Porsi Makan dan Minum Ibu Menyusui Untuk Kebutuhan Sehari

Bahan Makanan	Ibu Menyusui 0 - 12 Bulan	Keterangan per porsi
Nasi atau Makanan Pokok	6 porsi	• 100 g atau ¾ gelas nasi • 125 g atau 3 buah jagung ukuran sedang • 210 g atau 2 kentang ukuran sedang • 120 g atau 1 ½ potong singkong • 70 g atau 3 iris roti putih • 200 g atau 2 gelas mie basah
Protein Hewani Ikan, Telur, Ayam dan Lainnya	4 porsi	• 50 g atau 1 potong sedang ikan • 55 g atau 1 butir telur Ayam
Protein Nabati Tempe, Tahu, dan Lainnya	4 porsi	• 50 g atau 1 potong sedang tempe • 100 g atau 2 potong sedang tahu
Sayur-sayuran	4 porsi	100 g atau 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah
Buah-buahan	4 porsi	• 100 g atau 1 potong sedang pisang • 100-190 g atau 1 potong besar pepaya
Minyak/Lemak	6 porsi	5 g atau 1 sendok teh, bersumber dari pengolahan makanan seperti menggoreng, menumis, santan, kemiri, mentega dan sumber lemak lainnya. Minyak/lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan digoreng, ditumis atau dimasak dengan santan
Gula	2 porsi	10 g atau 1 sendok makan bersumber dari kue-kue manis, minum teh manis dan lain-lainnya

Minum Air Putih: 14 gelas/hari di 6 bulan pertama dan 12 gelas/hari pada 6 bulan kedua.

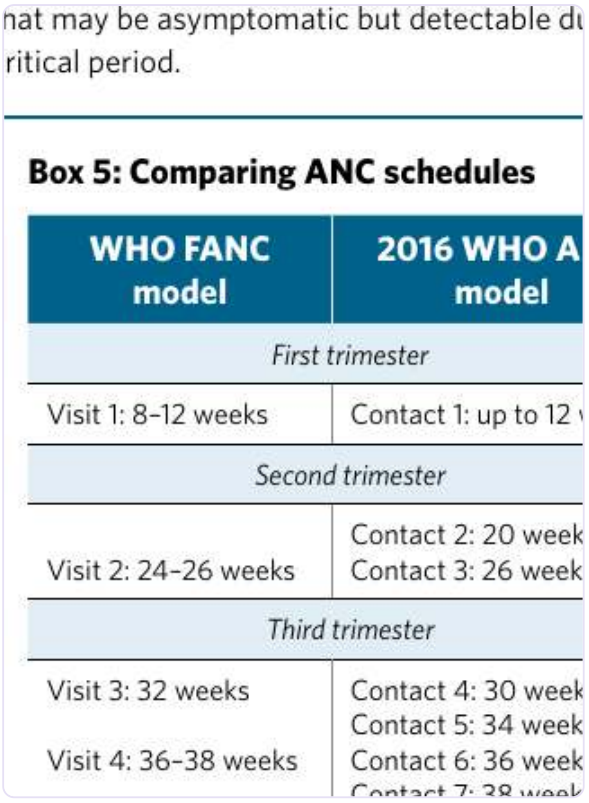
Konsultasikan porsi makan kepada tenaga kesehatan, perhatikan Indeks Massa Tubuh.

37

Dari Buku KIA 2024: cara memerah dan menyimpan ASI (tabel suhu dan lama penyimpanan) serta porsi makan dan minum ibu menyusui untuk kebutuhan sehari. *Sumber: Buku KIA Kemenkes RI 2024*

3. WHO ANC 2016: Ringkasan Cepat

1. Judul: **WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience**. Tujuannya bukan hanya ibu dan bayi selamat, tetapi juga **pengalaman hamil yang positif**.
2. **49 rekomendasi** dalam 5 kelompok: **A nutrisi**, **B penilaian ibu dan janin**, **C tindakan pencegahan**, **D keluhan fisiologis**, **E sistem kesehatan**.
3. Model **8 kontak**: **≤ 12, 20, 26, 30, 34, 36, 38, 40 minggu** (kembali di 41 minggu bila belum lahir). Lima kontak ada di trimester 3.
4. Rekomendasi kunci: **besi 30–60 mg + folat 400 µg setiap hari**; **kalsium 1,5–2 g** bila asupan rendah (cegah preeklamsia); **1 kali USG sebelum 24 minggu**; **CTG dan Doppler rutin tidak dianjurkan**; tes **HIV dan sifilis**; tanya **rokok, alkohol, dan KDRT**; **jahe, kamomil, B6, akupunktur** untuk mual; **ibu memegang catatan kehamilannya sendiri**.



nat may be asymptomatic but detectable du
ritical period.

Box 5: Comparing ANC schedules

WHO FANC model	2016 WHO A model
First trimester	
Visit 1: 8–12 weeks	Contact 1: up to 12
Second trimester	
Visit 2: 24–26 weeks	Contact 2: 20 week Contact 3: 26 week
Third trimester	
Visit 3: 32 weeks	Contact 4: 30 week
Visit 4: 36–38 weeks	Contact 5: 34 week Contact 6: 36 week Contact 7: 38 week

Dari WHO ANC 2016 (Box 5): jadwal model lama FANC 4 kunjungan dibandingkan model baru 8 kontak (≤ 12, 20, 26, 30, 34, 36, 38, 40 minggu). *Sumber: WHO ANC Guideline 2016*

Aspek	WHO 2016	Indonesia (Permenkes 21/2021, Buku KIA 2024)
Jumlah	**Minimal 8 kontak**	**Minimal 6 kali** (1–2–3)
USG	**1 kali sebelum 24 minggu**	**2 kali** (TM1 dan TM3, oleh dokter)
Suplemen	Besi + folat; kalsium bila asupan rendah	**TTD atau MMS** setiap hari
Infeksi	HIV, sifilis	**Triple eliminasi** (HIV, sifilis, hepatitis B)

Aspek	WHO 2016	Indonesia (Permenkes 21/2021, Buku KIA 2024)
Kesehatan jiwa	Tanya rokok, alkohol, KDRT	**Skrining kesehatan jiwa** TM1 dan TM3

4. Video YouTube Pendukung

Topik	Video	Kanal
Rekomendasi WHO ANC 2016 (WHO Myanmar)	WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience	WHO Myanmar
Update isi Buku KIA terbaru	UPDATE BUKU KIA TERBARU 2025 !! Banyak info penting !!	husna rizqia
Metode seven jumps dalam PBL	Metode Seven Jump dalam PBL	Kedokteran Sarjana FKIK ULM

Video per topik kuliah ada di bagian akhir rangkuman masing-masing KUL.

5. Ringkasan

1. **Modul**: blok 5 SKS, 4 minggu belajar + 1 minggu ujian; **UAB 60%**, lulus **≥ 60 (C)**. Ada **27 kuliah**; nomor di modul = nomor di web **+ 1** (contoh: modul kuliah 12 HPP = **KUL 11** di web).
2. Skenario tutorial: **abortus**, **KPD preterm/persalinan preterm**, **mastitis + masalah nifas**, **kandidiasis vulvovaginal**.
3. **Buku KIA 2024**: ANC **6 kali (1–2–3)**, dokter 2 kali dengan USG, **12T**, nifas **KF 1–4**, neonatus **KN 1–3**, ASI perah suhu ruang 4 jam, kulkas 2–3 hari.
4. **WHO 2016**: **8 kontak**, 49 rekomendasi, USG 1 kali < 24 minggu, besi + folat harian, kalsium untuk cegah preeklamsia.